KHAILLERY ADORNO

Khaillery Adorno Santiago
Psicóloga e Neuropsicóloga
CRP 09/17611

LAUDO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA

1. **Identificação Autor:**

Khaillery Adorno Santiago CRP 09/17611
Edilvana de Almeida Torres CRP:09/816

1.1. Identificação do cliente:

2. Nome: Willian Edvaldo Silva Rocha
3. Sexo: Masculino
4. Idade: 22 anos
5. DN: 09/08/2003
6. Estado Civil: Solteiro
7. Escolaridade: Ensino Superior Incompleto

2. **DESCRIÇÃO DA DEMANDA**

O presente documento tem como objetivo apresentar os dados obtidos por meio de uma avaliação neuropsicológica realizada no paciente Willian Edvaldo Silva Rocha, atualmente com 22 anos de idade. A avaliação foi solicitada a pedido do paciente, com o intuito de compreender seu funcionamento cognitivo, emocional e comportamental.

3. **PROCEDIMENTOS**

3.1 Entrevista de anamnese: O objetivo foi conhecer a demanda e o

histórico de vida de Willian Edvaldo Silva Rocha, além de fornecer orientações sobre o processo avaliativo.

3.2 Queixas principais:

A principal queixa refere-se à suspeita de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), motivada por dificuldades persistentes de organização, esquecimento frequente de informações consideradas pouco relevantes, dificuldade em manter atenção sustentada em atividades de baixo interesse e sensação subjetiva de mente acelerada, com múltiplos pensamentos simultâneos.

O paciente descreve padrão claro de hiperfoco em atividades de alto interesse, especialmente no contexto profissional, associado a elevado desempenho e produtividade. Em contraste, relata dificuldade significativa para estudar, planejar tarefas acadêmicas e manter constância em atividades que não despertam motivação intrínseca.

Também manifesta preocupação com sua busca intensa por estímulos, incluindo preferência por atividades altamente estimulantes e exposição a riscos tanto no trabalho quanto na vida pessoal, questionando se tais comportamentos estão associados à impulsividade, necessidade de estimulação ou características do funcionamento atencional.

Adicionalmente, refere queixas de memória funcional, especialmente esquecimentos do cotidiano (recados, compromissos, eventos recentes), com melhora quando utiliza estratégias externas, como anotações. As queixas tornaram-se mais evidentes no último ano, em parte devido à maior conscientização sobre esses comportamentos após feedback de pessoas próximas.

O paciente busca, por meio da avaliação neuropsicológica, compreender seu perfil cognitivo e atencional, esclarecer a presença ou não de TDAH e obter orientações que auxiliem na organização, gestão da atenção, tomada de decisões e equilíbrio entre desempenho elevado e segurança pessoal.

4. ANÁLISE

4.1. Análise do histórico de vida, familiar e dados complementares:

Paciente adulto jovem, sexo masculino, solteiro, com escolaridade de nível superior em andamento e atuação profissional como empresário. Relata desenvolvimento global sem intercorrências neurológicas ou médicas relevantes, negando doenças prévias, cirurgias ou uso atual de medicação. Não há histórico de internações ou condições neurológicas diagnosticadas.

O histórico escolar é marcado por dificuldades persistentes de aprendizagem, especialmente em matemática, com necessidade de aulas de reforço ao longo da escolarização básica. As notas foram descritas como medianas, com melhora no ensino médio em função de um modelo pedagógico mais prático e aplicado. Segundo relatos familiares, na infância apresentava comportamento calmo e tímido, porém com queixas frequentes de desatenção, "falta de foco" e dificuldades para estudar, apesar de ser considerado intelectualmente capaz.

Atualmente, refere alto desempenho cognitivo e profissional em contextos de interesse, especialmente no trabalho, onde é descrito como competente, resolutivo e eficiente. Em contrapartida, relata menor engajamento e organização em atividades acadêmicas, com estudo irregular, embora consiga desempenho satisfatório em avaliações.

No contexto familiar, ambos os pais são vivos, com escolaridade de nível médio completo e vínculo empregatício formal. Há irmãos adultos. O paciente refere histórico de dificuldades de aprendizagem em familiares, sem relato de transtornos psiquiátricos ou neurológicos relevantes na família.

Quanto aos hábitos de vida, apresenta rotina relativamente saudável, com alimentação equilibrada, prática intermitente de atividade física, consumo ocasional de álcool e sono médio de aproximadamente seis horas por noite, com episódios esporádicos de dificuldade para iniciar ou manter o sono. Nega uso de substâncias ilícitas. Relata sensibilidade atual a ambientes muito cheios e barulhentos, com tendência a evitá-los, embora negue histórico prévio desse padrão.

Do ponto de vista emocional, há indicação de sintomas leves de ansiedade e tristeza, além de estresse, irritabilidade e variações de energia, sem prejuízo funcional significativo. O paciente realizou psicoterapia por aproximadamente seis meses, com alta clínica, mantendo acompanhamento em caráter de manutenção.

Fundamentos teóricos e metodológicos: A Avaliação Neuropsicológica é um procedimento clínico-científico que analisa o funcionamento cognitivo, emocional e comportamental a partir da relação entre cérebro e comportamento. Atualmente, utiliza-se um modelo integrativo, combinando abordagens qualitativas e quantitativas para uma compreensão abrangente e funcional do paciente (Lezak et al., 2012; Strauss et al., 2021).

A abordagem qualitativa, baseada no Modelo Funcional de Luria, considera processos, estratégias, padrões de erro e sistemas funcionais envolvidos na execução das tarefas, permitindo entender como o indivíduo realiza determinada atividade (Luria, 1973). Já a abordagem quantitativa emprega instrumentos psicométricos padronizados, validados e normatizados, possibilitando mensurar o desempenho e compará-lo a grupos de referência (Schoenberg & Scott, 2011; APA, 2020).

No contexto clínico, essa avaliação contribui para o diagnóstico diferencial, o planejamento de intervenções e o acompanhamento terapêutico, integrando aspectos emocionais, sociais e culturais que influenciam o desempenho do paciente. A condução ética, técnica e baseada em evidências garante que os resultados ofereçam uma compreensão precisa das necessidades individuais e orientem estratégias de suporte adequadas (Conselho Federal de Psicologia, 2023; Heilbronner et al., 2020).

Testes psicológicos e neuropsicológicos:

a. **Escala Wechsler Abreviada de Inteligência (WASI):** Avaliar a eficiência cognitiva e funções intelectuais gerais, fornecendo estimativas de inteligência verbal, desempenho não verbal e QI total.
b. **Teste de Aprendizagem Auditivo de Rey (RAVLT):** Avaliar a memória declarativa episódica, fornecendo informações sobre aprendizagem auditivo-verbal, índices de interferência, retenção de informações e memória de reconhecimento.

c. **AQ-10 (Autism Spectrum Quotient – versão de 10 itens, versão para adultos, tradução brasileira, Instituto de Pesquisas Neuropsiquiátricas, Waldir Toledo, 2020).** O AQ-10 é um questionário breve de triagem, desenvolvido para rastrear indícios de características associadas ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).

d. **Bateria Fatorial de Personalidade (BFP):** Baseada no modelo dos cinco grandes fatores da personalidade: Extroversão, Socialização, Realização, Neuroticismo e Abertura às novas experiências

e. **Escala de Responsividade Social SRS-2:** Destinada a mensurar sintomas associados ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), classificando-os em níveis leves, moderados ou severos, com avaliação global e específica, agrupando sintomas em subcategorias compatíveis com DSM-5 e DSM-5-TR.

f. **ETDAH-Adulto Escala de Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade em Adultos**. Avaliar a presença e a intensidade de sintomas relacionados ao Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade em adultos, fornecendo indicadores sobre desatenção, impulsividade e hiperatividade.

g. **Técnica Projetiva de Desenho: Casa – Árvore – Pessoa (HTP):** Avaliar elementos da personalidade, áreas de conflito e aspectos afetivos e emocionais.

h. **BPA 2 – V. 5 Bateria Psicológica para Avaliação da Atenção:** Avaliar atenção concentrada, alternada e dividida.

i. **Teste dos Cinco Dígitos (FDT):** Avaliar controle inibitório e flexibilidade cognitiva.

j. **TEPIC-M-2 – Teste Pictórico de Memória – 2ª edição:** Avalia a memória visual episódica, contemplando principalmente os processos de codificação, armazenamento e evocação de informações visuais.

Instrumentos Formais: Todos os testes aplicados estão de acordo com o SATEPSI – Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos do Conselho Federal de Psicologia.

5. Testes Aplicados – Análise quantitativo e qualitativo/clínico

A) WASI - Escala Wechsler Abreviada de inteligência

Escala	Soma dos Escores *T*	Pontos Ponderados	Pontos Compostos (Q.I.)	Rank Percentil	Intervalo de Confiança 95%	Classificação (Tabela 27, pag. 67 - Manual)
Q.I Verbal	111	28,3	108	70	100 - 115	Média
Q.I. Execução	84	20,2	88	21	82 - 95	Média Inferior
ESCALA TOTAL (Q.I.T. 4 subtestes)	**195**	**53,5**	**98**	**45**	**92 - 104**	Média
ESCALA TOTAL (Q.I.T. 2 subtestes)	**85**	**20,5**	**87**	**19**	**81 - 95**	Média Inferior

Os resultados obtidos na Escala Wechsler Abreviada de Inteligência (WASI) indicam um perfil cognitivo heterogêneo, com discrepância significativa entre os domínios verbal e de execução.

No Quociente de Inteligência Verbal (Q.I. Verbal), o paciente apresentou escore composto de 108, correspondente ao percentil 70, com intervalo de confiança (95%) entre 100 e 115, situando-se na faixa Média. Esse desempenho sugere adequada capacidade de raciocínio verbal, compreensão conceitual, formação de conceitos e expressão verbal, indicando recursos preservados no processamento linguístico e abstrato verbal.

Em contrapartida, no Quociente de Inteligência de Execução (Q.I. de Execução), observou-se escore composto de 88, correspondente ao percentil 21, com intervalo de confiança (95%) entre 82 e 95, classificado na faixa Média Inferior. Esse resultado aponta para desempenho inferior ao esperado em tarefas que exigem raciocínio visuoespacial, organização perceptual, velocidade de processamento e resolução de problemas não verbais, sugerindo maior esforço cognitivo nessas demandas.

Na Escala Total com 4 subtestes, o Q.I. Total foi de 98, correspondente ao percentil 45, com intervalo de confiança (95%) entre 92 e 104, situando-se na faixa Média. Já na Escala Total com 2 subtestes, o Q.I. Total obtido foi de 87, no percentil 19, com intervalo de confiança (95%) entre 81 e 95, classificado como Média Inferior, refletindo maior impacto das habilidades de execução quando avaliadas de forma abreviada.

A discrepância observada entre o Q.I. Verbal e o Q.I. de Execução é clinicamente relevante e sugere um perfil em que habilidades verbais funcionam como fator

compensatório, enquanto as habilidades executivas e visuoconstrutivas mostram-se relativamente mais frágeis. Esse padrão é compatível com relatos de bom desempenho em atividades de interesse, raciocínio verbal preservado e dificuldades em organização, planejamento, gestão do tempo e atenção sustentada, devendo ser interpretado em conjunto com os demais instrumentos neuropsicológicos e dados clínicos.

O desempenho intelectual global situa-se dentro da média, não havendo indicativos de deficiência intelectual. Contudo, a assimetria entre os índices sugere impacto funcional em tarefas que exigem maior controle executivo e organização perceptual.

B)Teste de Aprendizagem Auditivo de Rey (RAVLT):

Avaliar a memória declarativa episódica, fornecendo informações sobre aprendizagem auditivo-verbal, índices de interferência, retenção de informações e memória de reconhecimento.

O desempenho do paciente no Teste de Aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey (RAVLT) evidencia um perfil de memória verbal com rendimento global abaixo do esperado, associado a dificuldades no processo de aquisição inicial e consolidação das informações, com preservação relativa dos mecanismos de interferência.

Nas tentativas iniciais de aprendizagem (A1), o paciente apresentou desempenho no percentil 5, classificado como Médio Inferior – Possível Déficit, indicando baixa eficiência na codificação inicial de informações verbais, possivelmente relacionada a dificuldades atencionais no primeiro contato com o material. Observa-se melhora progressiva ao longo das tentativas subsequentes (A2 a A4), com desempenho situado na faixa média (percentil 25), sugerindo capacidade de aprendizagem gradual quando há repetição e maior familiaridade com o estímulo.

Entretanto, apesar dessa progressão, o desempenho total nas tentativas de aprendizagem (Escore Total = 40) permaneceu na faixa Média Inferior – Possível Déficit (percentil entre 5 e 25), indicando aprendizagem verbal menos eficiente do que o esperado, com curva de aprendizagem aquém da média normativa.

O reconhecimento da Lista A situou-se na faixa média (percentil 25), sugerindo que, quando há pistas externas, o paciente consegue acessar parte das informações previamente apresentadas, o que indica melhor desempenho em tarefas de reconhecimento do que de evocação espontânea.

A aprendizagem ao longo das tentativas apresentou classificação Média Típica (percentil entre 50 e 75), evidenciando que, embora o desempenho inicial seja baixo, o paciente demonstra capacidade de ganho com repetição, reforçando a hipótese de que a principal limitação esteja relacionada à atenção e à organização da informação, e não a um comprometimento mnésico estrutural primário.

A velocidade de esquecimento apresentou-se na faixa Média Inferior – Possível Déficit (percentil entre 5 e 25), sugerindo retenção menos eficiente ao longo do tempo, com tendência à perda acelerada do material apreendido.

Por outro lado, os índices de interferência proativa e retroativa situam-se na faixa Média Superior – Típica (percentil 75), indicando boa resistência à interferência, o que sugere preservação dos mecanismos de controle mnésico frente a informações concorrentes.

	Pontos Brutos	Percentil	Classificação Interpretação Clínica
A1	4	5	Médio Inferior - Possível Déficit
A2	7	25	Médio - Típico
A3	9	25	Médio - Típico
A4	10	25	Médio - Típico
A5	10	> 5 e < 25	Médio Inferior - Possível Déficit
B1	4	25	Médio - Típico
A6	10	> 25 e < 50	Médio - Típico
A7	9	25	Médio - Típico
Reconhecimento Lista A	11	25	Médio - Típico
Escore Total	40	> 5 e < 25	Médio Inferior - Possível Déficit
Aprend. longo das Tentativas	20	> 50 e < 75	Médio - Típico
Velocidade de Esquecimento	0,90	> 5 e < 25	Médio Inferior - Possível Déficit
Interferência Proativa	1,00	75	Médio Superior - Típico
Interferência Retroatro	1,00	75	Médio Superior - Típico

C) AQ-10 (Autism Spectrum Quotient – versão de 10 itens, para adultos)

Instrumento breve de triagem para características de Transtorno do Espectro do Autismo em adultos sem deficiência intelectual. Avalia aspecto de sensibilidade sensorial,

cognição social, interesses restritos, percepção de padrões e preferências por detalhes ou regularidade. Pontuação igual ou superior a 6 de 10 sugere necessidade de avaliação diagnóstica especializada.

No AQ-10, instrumento de rastreamento breve para características do Transtorno do Espectro Autista em adultos, o paciente obteve pontuação total de 6 pontos.

De acordo com os critérios de interpretação do instrumento, escores iguais ou superiores a 6 indicam resultado positivo para rastreamento, sugerindo presença clinicamente relevante de traços autísticos, especialmente relacionados à comunicação social, padrões de interesse e estilo cognitivo.

Ressalta-se que o AQ-10 não possui finalidade diagnóstica, funcionando como ferramenta de triagem. Dessa forma, o resultado não confirma diagnóstico de TEA de forma isolada, mas reforça a necessidade de investigação clínica aprofundada, com integração dos dados da anamnese, observação comportamental e demais instrumentos neuropsicológicos e socioemocionais.

D) Bateria Fatorial de Personalidade

Baseada no modelo dos cinco grandes fatores da personalidade: Extroversão, Socialização, Realização, Neuroticismo e Abertura às novas experiências.

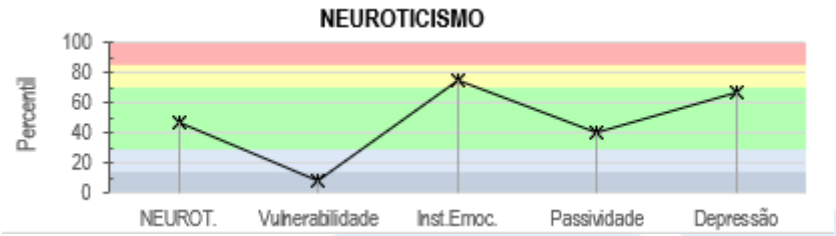
Fator	Pts Bts	Média	D.P.	Z-Score	Ponder	Percentil	Classificação
Neuroticismo NN	2,98	3,06	1	-0,077	9,8	47	Médio
Vulnerabilidade N1	1,56	3,25	1,18	-1,436	5,7	8	Muito Baixo
Instabilidade Emocional N2	4,33	3,43	1,37	0,659	12,0	75	Alto
Passividade/Falta de energia N3	3,17	3,47	1,22	-0,249	9,3	40	Médio
Depressão N4	2,88	2,36	1,14	0,452	11,4	67	Médio

Fator	Pts Bts	Média	D.P.	Z-Score	Ponder	Percentil	Classificação
Extroversão EE	4,39	4,28	0,83	0,137	10,4	55	Médio
Comunicação E1	5,83	4,24	1,22	1,306	13,9	90	Muito Alto
Altivez E2	2,57	3,67	1,04	-1,056	6,8	15	Muito Baixo
Dinamismo E3	5,60	4,78	0,99	0,828	12,5	80	Alto
Interações Sociais E4	3,57	4,74	1,08	-1,082	6,8	14	Muito Baixo

Fator	Pts Bts	Média	D.P.	Z-Score	Ponder	Percentil	Classificação
Socialização SS	4,46	5,04	0,8	-0,727	7,8	23	Baixo
Amabilidade S1	4,00	5,32	0,99	-1,333	6,0	9	Muito Baixo
Pro-Sociabilidade S2	5,50	5,23	1,1	0,245	10,7	60	Médio
Confiança nas pessoas S3	3,88	4,57	1,01	-0,688	7,9	25	Baixo

Fator	Pts Bts	Média	D.P.	Z-Score	Ponder	Percentil	Classificação
Realização RR	4,19	4,94	0,84	-0,895	7,3	19	Baixo
Competência R1	6,10	5,19	0,93	0,978	12,9	84	Alto
Ponderação/Prudência R2	1,75	4,99	1,17	-2,769	1,7	0	Muito Baixo
Empenho/Comprometimento R3	4,71	4,65	1,06	0,061	10,2	52	Médio

Fator	Pts Bts	Média	D.P.	Z-Score	Ponder	Percentil	Classificação
Abertura AA	5,04	4,65	0,75	0,526	11,6	70	Médio
Abertura a Ideias A1	5,30	4,59	1,04	0,683	12,0	75	Alto
Liberalismo A2	5,00	4,74	1,05	0,248	10,7	60	Médio
Busca por novidades A3	4,83	4,61	1,02	0,219	10,7	59	Médio

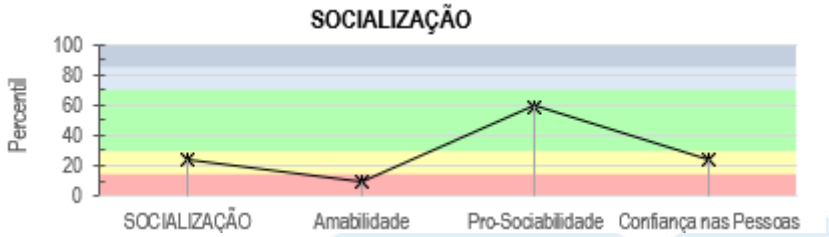


Neuroticismo (NN)

O fator Neuroticismo global situou-se na faixa Média (percentil 47), sugerindo regulação emocional globalmente preservada. Observa-se, entretanto, elevação clinicamente relevante em Instabilidade Emocional (N2 – percentil 75), indicando maior reatividade emocional, oscilação afetiva e sensibilidade a estressores. Em contraste, Vulnerabilidade (N1) apresentou classificação Muito Baixa (percentil 8), sugerindo boa percepção de autossuficiência e menor tendência à vivência de fragilidade emocional, o que pode mascarar ou compensar reações emocionais intensas em contextos específicos.

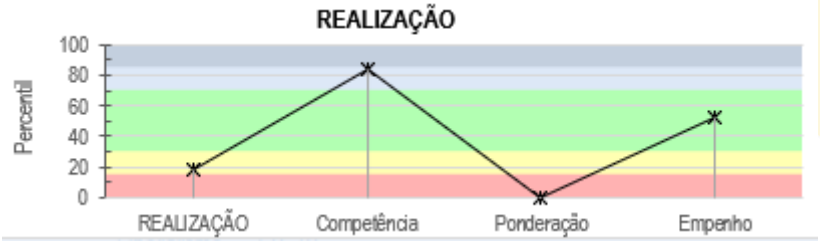
Extroversão (EE)

O fator Extroversão global situou-se na faixa Média (percentil 55). Contudo, observa-se perfil assimétrico: Comunicação (E1) apresentou classificação Muito Alta (percentil 90), indicando facilidade expressiva, assertividade verbal e habilidade comunicativa. Em oposição, Interações Sociais (E4) e Ativez (E2) situaram-se na faixa Muito Baixa (percentis 14 e 15), sugerindo baixa busca espontânea por interação social e menor necessidade de estímulo social contínuo, com tendência a seletividade nos vínculos e contextos de interação. O fator Dinamismo (E3) apresentou classificação Alta (percentil 80), indicando energia e iniciativa quando engajado em atividades de interesse.



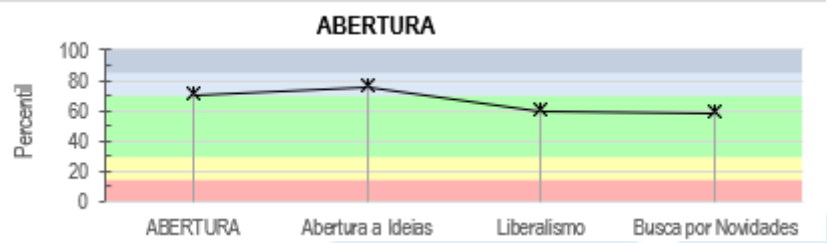
Socialização (SS)

O fator Socialização global apresentou classificação Baixa (percentil 23), indicando perfil mais reservado, seletivo e cauteloso nas relações interpessoais. Destaca-se Amabilidade (S1) em nível Muito Baixo (percentil 9), sugerindo menor tendência à complacência, maior assertividade e possível rigidez relacional. Pro-sociabilidade (S2) manteve-se na faixa Média (percentil 60), indicando preservação de comportamentos cooperativos quando considerados relevantes. Confiança nas pessoas (S3) apresentou classificação Baixa (percentil 25), sugerindo postura mais vigilante e desconfiada em relações interpessoais.



Realização (RR)

O fator Realização global situou-se na faixa Baixa (percentil 19), indicando dificuldades relativas em planejamento, organização e constância comportamental. Observa-se, entretanto, Competência (R1) em nível Alto (percentil 84), sugerindo boa percepção de capacidade intelectual e eficácia na resolução de problemas. Em contrapartida, Ponderação/Prudência (R2) apresentou classificação Muito Baixa (percentil 7), indicando tendência à impulsividade, tomada de decisão rápida e menor consideração prévia de riscos, aspecto clinicamente relevante frente aos relatos de busca por estímulo e exposição a situações de risco. Empenho/Comprometimento (R3) manteve-se na faixa Média (percentil 52).



Abertura à Experiência (AA)

O fator Abertura global apresentou classificação Média (percentil 70), indicando flexibilidade cognitiva, curiosidade intelectual e abertura a novas experiências. Os subfatores Abertura a Ideias (A1), Liberalismo (A2) e Busca por Novidades (A3) mantiveram-se todos na faixa Média (percentis entre 59 e 75), sugerindo equilíbrio entre exploração cognitiva e pragmatismo.

O perfil de personalidade avaliado pela BFP sugere um indivíduo com bons recursos cognitivos e comunicativos, porém com dificuldades na autorregulação emocional em contextos específicos, organização comportamental e ponderação de riscos. A combinação de alta competência percebida, baixa prudência, dinamismo elevado em atividades de interesse e seletividade social é compatível com perfis em que o funcionamento executivo e atencional exerce papel central na modulação do comportamento.

Os traços de personalidade identificados não configuram, isoladamente, transtornos de personalidade, mas modulam significativamente o funcionamento cognitivo, emocional e social do paciente, devendo ser considerados na formulação diagnóstica e nas recomendações clínicas.

E) Escala de Responsividade Social - 2 (SRS-2)

Autorrelato - o próprio						
Fator	Pts Brts	T-Score	Percentil	Ponderado	Z-score	Classificação (pag 11)
Percepção Social (Perc.S.)	13	70	98	16	2	Nível Moderado
Cognição Social (Cog.S.)	13	57	75	12,1	0,7	Dentro dos limites Normais
Comunicação Social (Com.S.)	24	58	78	12,4	0,8	Dentro dos limites Normais
Motivação Social (Mot.S.)	7	43	25	7,9	-0,7	Dentro dos limites Normais
Padrões Restritos e Repetitivos (PRR)	14	60	85	13	1	Nível Leve
Comunicação e Interação Social (CIS)	57	57	75	12,1	0,7	Dentro dos limites Normais
Pontuação SRS-2 Total	**71**	**58**	**80**	**12,4**	**0,8**	Dentro dos limites Normais

Heterorrelato - Namorada						
Fator	Pts Brts	T-Score	Percentil	Ponderado	Z-score	Classificação (pag 11)
Percepção Social (Perc.S.)	8	56	72	11,8	0,6	Dentro dos limites Normais
Cognição Social (Cog.S.)	13	57	76	12,1	0,7	Dentro dos limites Normais
Comunicação Social (Cog.S)	21	57	74	12,1	0,7	Dentro dos limites Normais
Motivação Social (Mot.S.)	6	47	38	9,1	-0,3	Dentro dos limites Normais
Padrões Restritos e Repetitivos (PRR)	9	55	70	11,5	0,5	Dentro dos limites Normais
Comunicação e Interação Social (CIS	48	55	70	11,5	0,5	Dentro dos limites Normais
Pontuação SRS-2 Total	**57**	**55**	**71**	**11,5**	**0,5**	Dentro dos limites Normais

Autorrelato (Paciente)

No autorrelato, a pontuação total do SRS-2 foi de 71 pontos (T-score = 58; percentil 80), classificada dentro dos limites normais, sugerindo ausência de comprometimento clinicamente significativo global na responsividade social.

Na análise das subescalas, observa-se elevação específica em Percepção Social (T-score = 70; percentil 98), classificada como Nível Moderado, indicando maior esforço ou sensibilidade subjetiva na leitura de sinais sociais, pistas não verbais e interpretação de contextos sociais. As demais subescalas de Cognição Social, Comunicação Social e Motivação Social situaram-se dentro dos limites normativos, indicando funcionamento preservado nesses domínios.

No domínio relacionado aos critérios do DSM-5, o fator Padrões Restritos e Repetitivos (PRR) apresentou classificação em Nível Leve (T-score = 60; percentil 85), sugerindo presença discreta de rigidez cognitiva, interesses específicos ou padrões comportamentais repetitivos, sem impacto funcional global relevante. O índice de Comunicação e Interação Social (CIS) manteve-se dentro dos limites normais.

Heterorrelato (Namorada)

No heterorrelato, a pontuação total do SRS-2 foi de 57 pontos (T-score = 55; percentil 71), igualmente classificada dentro dos limites normais, indicando ausência de prejuízos clinicamente significativos na responsividade social observada por terceiros.

Todas as subescalas — Percepção Social, Cognição Social, Comunicação Social e Motivação Social — situaram-se dentro da faixa normativa, assim como os domínios correspondentes aos critérios do DSM-5 (PRR e CIS), não sendo observados indicadores de comprometimento social funcional do ponto de vista externo.

A comparação entre autorrelato e heterorrelato evidencia leve discrepância entre a percepção subjetiva do paciente e a observação externa, com o paciente relatando maior sensibilidade ou esforço interno em aspectos de percepção social, não corroborado de forma significativa pela informante. Esse padrão é compatível com indivíduos que apresentam alto grau de autorreflexão, monitoramento social interno elevado e possível sobrecarga cognitiva em contextos sociais, sem prejuízo observável no funcionamento social cotidiano.

Os resultados do SRS-2 indicam funcionamento social globalmente preservado, com elevação pontual em autorrelato relacionada à percepção social e padrões restritos leves, devendo tais achados ser interpretados à luz do perfil cognitivo, atencional e de personalidade do paciente.

F) ETDAH-Adulto Escala de Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade em Adultos.

É um instrumento psicométrico de avaliação de sintomas associados ao TDAH em indivíduos a partir da idade adulta.

Respondente	FATOR	Pontos Brutos	Percentil	Classificação
auto	Fator 1 - Desatenção (D)	63	> 95 e < 99	Superior
	Fator 2 - Impulsividade (I)	53	> 85 e < 90	Superior
	Fator 3 - Aspectos Emocionais (AE)	12	> 90 e < 95	Superior
	Fator 4 - Autoregulação da Atenção, Motivação e Ação (AMAA)	8	5	Inferior
	Fator 5 - Hiperatividade (H)	29	99	Superior

Os resultados obtidos no ETDAH-AD evidenciam elevação clinicamente significativa de sintomas compatíveis com TDAH em adultos, com predomínio dos domínios de

desatenção, hiperatividade e impulsividade, associados a impacto relevante na auto regulação atencional e comportamental.

No Fator 1 – Desatenção (D), o paciente apresentou pontuação classificada como Superior, com percentil entre 97,6, indicando frequentes dificuldades em manter atenção sustentada, organização de tarefas, gerenciamento do tempo e seguimento de instruções, especialmente em atividades de menor interesse.

O Fator 2 – Impulsividade (I) situou-se na faixa Média Superior, sugerindo tendência a respostas rápidas, tomada de decisões precipitadas e menor inibição comportamental, com possível impacto na ponderação de consequências.

No Fator 3 – Aspectos Emocionais (AE), o desempenho foi classificado como Superior, indicando intensa reatividade emocional, oscilação afetiva e sensibilidade a frustrações, frequentemente associadas ao funcionamento do TDAH em adultos.

O Fator 4 – Autorregulação da Atenção, Motivação e Ação (AMAA) apresentou classificação Inferior / Limítrofe, evidenciando déficits relevantes na capacidade de manter foco, iniciar e sustentar ações, organizar metas e concluir tarefas, mesmo quando há compreensão adequada das demandas.

Por fim, **o Fator 5 – Hiperatividade (H)** apresentou pontuação Muito Superior (percentil 99,8), indicando nível elevado de inquietação interna, necessidade constante de estímulo, aceleração mental e comportamental, ainda que nem sempre expressa de forma motora clássica, compatível com apresentações do TDAH na vida adulta.

O perfil identificado no ETDAH-AD é fortemente sugestivo de TDAH em adultos, com predomínio combinado de desatenção, hiperatividade e impulsividade, associado a importante prejuízo na auto regulação atencional e motivacional. Os achados são coerentes com as queixas clínicas, histórico de desenvolvimento, resultados cognitivos (WASI, RAVLT) e traços de personalidade, reforçando a hipótese diagnóstica.

Os resultados do ETDAH-AD indicam presença significativa de sintomas compatíveis com Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade em adultos,

devendo ser integrados aos demais dados clínicos e neuropsicológicos para fechamento diagnóstico.

G) Técnica Projetiva de Desenho: Casa – Árvore – Pessoa (HTP):

Avaliar elementos da personalidade, áreas de conflito e aspectos afetivos e emocionais.

A análise integrada do HTP (Casa–Árvore–Pessoa), do inquérito associado e dos desenhos livres sugere um funcionamento emocional marcado por necessidade de segurança, busca por estabilidade e preservação de recursos adaptativos, com indícios de conflitos internos manejados de forma predominantemente racional.

No desenho da casa, observam-se elementos associados à representação de ambiente familiar e afetivo como fonte de referência importante, com destaque para temas relacionados à infância, proteção e expectativa de futuro. O conteúdo verbal associado indica percepção de experiências passadas com ambivalência emocional, reconhecendo vivências difíceis, porém com elaboração cognitiva e capacidade de ressignificação.

A árvore foi descrita e simbolizada como resistente, adaptável e capaz de sobreviver em condições adversas, o que sugere recursos de resiliência, persistência e enfrentamento. A presença de referências a feridas e necessidade de adaptações indica reconhecimento de dificuldades ou impactos emocionais prévios, sem sinais de desorganização psíquica, mantendo coerência narrativa e simbolização adequada.

No desenho da pessoa e no inquérito correspondente, emergem conteúdos relacionados à autoimagem, identidade e projetos futuros, com valorização de aspectos como autonomia, propósito e desejo de deixar um legado. São mencionadas preocupações com o futuro e com a organização da própria vida, associadas a sentimentos de responsabilidade e auto exigência. Observa-se também indicação de dificuldades na organização e execução de metas, coerentes com os achados cognitivos e atencionais previamente identificados.

Os desenhos livres reforçam um estilo de funcionamento caracterizado por imaginação preservada, pensamento simbólico adequado e capacidade de expressão gráfica

organizada, sem indicadores de ruptura com a realidade, ideação bizarra ou empobrecimento afetivo.

Os instrumentos projetivos não indicam sinais de comprometimento psicopatológico grave, sugerindo funcionamento emocional globalmente preservado, com conflitos internos manejados por meio de racionalização, busca por controle e investimento em projetos futuros. Os achados devem ser compreendidos como complementares aos dados objetivos da avaliação neuropsicológica.

H) BPA 2 – V. 5 Bateria Psicológica para Avaliação da Atenção. Objetivos: Avaliar atenção concentrada, alternada e dividida.

Teste	Pontos Brutos	Erros	Omissões	Auto Correções	TOTAL	Percentil	Classificação
Atenção Concentrada - AC	120	1	3	0	116	> 80 e < 90	Superior
Atenção Dividida - AD	120	0	8	0	112	> 90 e < 99	Superior
Atenção Alternada - AA	120	1	6	0	113	> 60 e < 70	Médio Superior
Atenção Geral	360	2	17	0	341	> 90 e < 95	Superior

Os resultados obtidos na Bateria Psicológica para Avaliação da Atenção (BPA) indicam desempenho atencional global preservado e acima da média, com bom rendimento nos diferentes tipos de atenção avaliados.

Na Atenção Concentrada (AC), o paciente apresentou escore total de 116, com percentil entre 80 e 90, classificado como Superior, evidenciando boa capacidade de manter foco em tarefas monótonas, com baixo índice de erros e omissões, sugerindo controle atencional eficaz quando a tarefa é estruturada.

Na Atenção Dividida (AD), o escore total foi de 112, com percentil acima de 90, também classificado como Superior, indicando habilidade preservada para lidar simultaneamente com múltiplas demandas atencionais, sem aumento significativo de erros.

Na Atenção Alternada (AA), o paciente obteve escore total de 113, com percentil entre 60 e 70, classificado como Médio Superior, sugerindo boa flexibilidade atencional e

capacidade de alternar o foco entre estímulos distintos, ainda que com discreto aumento de omissões em comparação às demais condições.

Por fim, a Atenção Geral apresentou escore total de 341, com percentil entre 90 e 95, classificado como Superior, indicando funcionamento atencional global acima da média, com adequada velocidade, precisão e controle dos recursos atencionais.

O perfil observado na BPA indica que o paciente apresenta capacidade atencional objetiva preservada e eficiente em contextos estruturados e de curta duração, com bom controle de erros. Esse padrão sugere que as queixas atencionais relatadas no cotidiano podem estar mais relacionadas a dificuldades de autorregulação, motivação, organização e manutenção do foco em tarefas de baixo interesse, do que a um déficit atencional primário.

I) Teste dos Cinco Dígitos (FDT).

Avaliar controle inibitório e flexibilidade cognitiva.

Tempo		Tempo em segundos	Percentil
Processos Automáticos	Leitura	0,19	>95
	Contagem	0,27	>95
Processos Controlados	Escolha	0,35	>95
	Alternância	0,39	>95
	Inibição	0,16	>95
	Flexibilidade	0,2	>95

Erros		Qtde de erros	Percentil
Processos Automáticos	Leitura	0	> 95
	Contagem	3	< 5
Processos Controlados	Escolha	6	< 5
	Alternância	2	> 5 e < 25

Os resultados do FDT evidenciam um perfil de desempenho muito elevado em velocidade de processamento e controle executivo, associado, entretanto, a aumento de erros em condições específicas, sugerindo estilo de resposta acelerado com menor monitoramento em algumas tarefas.

Tempo de Execução: Nos processos automáticos (Leitura e Contagem), o paciente apresentou tempos extremamente reduzidos, com desempenho acima do percentil 95, classificados como Muito Superior, indicando velocidade de processamento excepcional e automatização eficiente.

Nos processos controlados (Escolha, Alternância, Inibição e Flexibilidade), manteve desempenho acima do percentil 95, com classificações predominantemente Muito Superior, evidenciando rápida capacidade de tomada de decisão, alternância de regras e flexibilidade cognitiva, além de bom controle inibitório em termos de tempo de resposta.

Padrão de Erros: Apesar do desempenho temporal elevado, observa-se aumento significativo de erros em tarefas de Contagem e Escolha, ambas classificadas como Deficitárias, sugerindo redução da precisão quando há necessidade de monitoramento atencional contínuo. Na tarefa de Alternância, os erros situam-se na faixa Média Inferior, enquanto a Leitura manteve precisão dentro da média.

O padrão observado no FDT sugere um estilo cognitivo caracterizado por respostas muito rápidas, elevada eficiência de processamento e boa flexibilidade cognitiva, associado a tendência à impulsividade e menor checagem da resposta em determinadas condições, especialmente quando as demandas exigem desaceleração voluntária e controle atencional fino.

J) TEPIC-M-2 – Teste Pictórico de Memória – 2ª edição

Avalia a memória visual episódica, contemplando principalmente os processos de codificação, armazenamento e evocação de informações visuais.

De acordo com a tabela normativa geral correspondente à faixa etária, o paciente obteve desempenho classificado como Superior, situado no percentil 90.

Esse resultado indica funcionamento superior da memória visual episódica, com eficiente capacidade de codificação, armazenamento e evocação de informações visuais, sem dependência de estratégias verbais. O desempenho sugere boa aprendizagem visual, adequada retenção dos estímulos apresentados e recuperação eficaz do material após o intervalo.

Não foram observados indicadores de comprometimento mnésico visual, sendo o desempenho acima do esperado para a faixa etária, o que evidencia recursos cognitivos preservados e potencializados nesse domínio.

O desempenho superior no TEPIC-M-2 reforça a preservação da memória visual episódica, indicando que eventuais queixas de memória referidas pelo paciente estão mais relacionadas a fatores atencionais, executivos ou motivacionais do que a déficits amnésicos estruturais.

6. COMPREENSÃO GLOBAL DO CASO:

O paciente apresentou classificação Média no Q.I. Verbal (QIV = 108; percentil 70) e desempenho Médio Inferior no Q.I. de Execução (QIE = 88; percentil 21), resultando em Q.I. Geral Médio (QIT = 98; percentil 45) na versão com quatro subtestes do WASI. Esse perfil evidencia assimetria cognitiva clinicamente relevante, com habilidades verbais preservadas e superiores às habilidades visuoespaciais e de execução, sugerindo que os recursos linguísticos e de raciocínio verbal funcionam como fatores compensatórios frente a demandas não verbais, organizacionais e executivas.

Memória: A avaliação da memória revelou perfil heterogêneo. No RAVLT, observou-se desempenho Médio Inferior com possível déficit na aquisição inicial e na velocidade de esquecimento, associado a dificuldades de codificação e consolidação da informação verbal, apesar de aprendizagem progressiva com repetição e boa resistência à interferência proativa e retroativa. Em contraste, o TEPIC-M-2 indicou desempenho Superior (percentil 90), evidenciando memória visual episódica preservada e acima do esperado para a idade, afastando hipótese de comprometimento mnésico estrutural. Esse padrão sugere que as queixas de memória são secundárias a dificuldades atencionais e executivas, especialmente no domínio verbal.

Funções Executivas e Atenção: A avaliação atencional objetiva, por meio da BPA, demonstrou atenção concentrada, dividida e geral em níveis Superiores, com atenção alternada em faixa Médio Superior, indicando capacidade atencional estrutural preservada em contextos estruturados e de curta duração. No FDT, observou-se velocidade de processamento Muito Superior e excelente flexibilidade cognitiva, porém com aumento de erros em condições que exigem maior monitoramento da resposta, sugerindo estilo cognitivo acelerado, com tendência à impulsividade e menor checagem da precisão. O ETDAH-AD reforça esse achado ao apontar elevação clinicamente

significativa em Desatenção, Hiperatividade e Impulsividade, além de déficit marcante em autorregulação da atenção, motivação e ação, configurando impacto funcional relevante no cotidiano.

Aspectos Socioemocionais e Personalidade: A BFP evidenciou perfil de personalidade heterogêneo, com instabilidade emocional elevada, alta competência percebida, porém baixa prudência e planejamento, indicando tendência a decisões impulsivas, busca por estímulos e exposição a riscos, em consonância com os relatos clínicos. Observou-se também seletividade social, menor confiança interpessoal e baixa necessidade de interação social contínua, sem prejuízo comunicativo. O SRS-2, tanto no autorrelato quanto no heterorrelato, apresentou funcionamento social globalmente dentro dos limites normativos, com elevação pontual em percepção social e padrões restritos leves no autorrelato, não corroborados de forma significativa por informante externo. O AQ-10 apresentou pontuação 6, positiva para rastreamento, porém não sustentada por prejuízo funcional social, quando integrados os demais instrumentos e a anamnese.

Síntese Diagnóstica (DSM-5-TR / CID-11)

À luz dos critérios diagnósticos do DSM-5-TR e da CID-11, os achados são compatíveis com:

- **Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH), apresentação combinada-** DSM-5-TR: 314.01 / CID-11: 6A05.2

Não foram encontrados critérios suficientes para diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, sendo os traços identificados melhor explicados por funcionamento atencional, estilo cognitivo acelerado e características de personalidade, sem prejuízo social clinicamente significativo.

7. ENCAMINHAMENTO

Considerando os achados desta avaliação neuropsicológica, recomenda-se:

Acompanhamento Psiquiátrico:
Avaliação médica para consideração de intervenção farmacológica específica para

TDAH, com foco na melhora da auto regulação atencional, controle da impulsividade e organização comportamental, se clinicamente indicado.

Intervenção Psicoterapêutica Individual:

Psicoterapia com abordagem cognitivo-comportamental ou integrativa, voltada para:

- Treino de funções executivas (planejamento, organização, gestão do tempo);
- Estratégias de autorregulação emocional;
- Manejo da impulsividade e tomada de decisões;
- Desenvolvimento de estratégias compensatórias para rotina acadêmica e profissional.

Apoio Familiar e Social:

Psicoeducação sobre TDAH em adultos, com orientação para adaptações ambientais, organização de rotinas, divisão de tarefas e manejo de demandas, favorecendo redução de estresse e melhora do funcionamento global.

Recomenda-se reavaliação neuropsicológica após 12 meses, com o objetivo de monitorar a evolução do funcionamento cognitivo, atencional e executivo, bem como avaliar a eficácia das intervenções terapêuticas e/ou farmacológicas implementadas, permitindo ajustes no plano de tratamento conforme a evolução clínica do paciente.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Este documento contém informações sigilosas referentes ao paciente avaliado. A responsabilidade pela preservação da confidencialidade recai sobre os profissionais que receberam este laudo, devendo ser compartilhado apenas quando estritamente necessário e exclusivamente com pessoas envolvidas no cuidado ou acompanhamento do paciente.
- O presente laudo foi elaborado em conformidade com as diretrizes do Manual de Elaboração de Documentos Escritos instituído pela Resolução CFP nº 007/2003, garantindo o cumprimento integral dos princípios éticos, técnicos e legais inerentes ao processo de avaliação psicológica.

- Este laudo contém 25 páginas, todas devidamente assinadas pelo profissional responsável pela avaliação, assegurando autenticidade, integridade e validade das informações apresentadas.

8. Referências

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. *Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais – DSM-5*. Porto Alegre: Artmed, 2014.

BARON-COHEN, S.; ALLISON, C.; AUYEUNG, B.; et al. *Autism Spectrum Quotient – AQ-10 (versão para adultos)*. Tradução e adaptação: Instituto de Pesquisas Neuropsiquiátricas (Waldir Toledo), 2020.

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA – CFP. *Manual de avaliação neuropsicológica*. Brasília: CFP, 2023.

CONSTANTINO, J. N.; GRUBER, C. P. *Escala de Responsividade Social – SRS-2*. Versão brasileira: Lisandra Borges. São Paulo: Hogrefe, 2021.

NUNES, C. H. S. S.; HUTZ, C. S.; NUNES, M. F. O. *Bateria Fatorial de Personalidade – BFP*. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2009.

RUEDA, F. J. M. *Bateria Psicológica para Avaliação da Atenção – BPA*. São Paulo: Vetor, 2013.

Rueda, F. J. M., & Sisto, F. F. (2013). *TEPIC-M-2 – Teste Pictórico de Memória – Manual Técnico*. São Paulo: Casa do Psicólogo

SILVA, A. L.; CONNERS, C. K. *ETDAH – Escala para Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (versão adulto)*. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2014.

WECHSLER, D. *WASI: Escala Wechsler Abreviada de Inteligência*. Adaptação e padronização brasileira: R. F. de Souza; C. H. de Primi. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2014.

17 de Janeiro de 2026.

_____

Khaillery Adorno Santiago
Psicóloga e Neuropsicóloga
CRP 09/17611
Emitente do Laudo Neuropsicológico

_____

Edilvana de Almeida Torres
Neuropsicóloga CRP-09/816
Emitente do Laudo Neuropsicológico

_____

Paciente / Responsável Legal
Confirma ciência e recebimento das orientações relacionadas à avaliação.